

Fecha Última Actualización: 25-06-2022 10:30:23

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Jesus Rafael Moreno Ramirez
Edad : 60a 0m 22d
Dirección : Rojas Magallanes 937

Rut : 26.427.979-8
Fecha Nacto: 03/06/1962
Comuna : La Florida

N° Archivo : 2102911
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 3300 0935

N° Epicrisis
312324

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Unidad Intermedio Coronaria

Fecha Ingreso : 19/06/2022 17:34

Días Estadía : 6

Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Egreso : 25/06/2022 10:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

ingresa de manera electiva para cirugía de revascularización miocárdica

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Jesús Rafael Moreno Ramírez
RUT: 26427979-8
Edad: 60 años
FECHA DE INGRESO HSR/Unidad Coronaria: 19/06/2022
FECHA DE INGRESO UCI: 20/06/2022
FECHA DE INGRESO UTIM: 23/06/2022

Antecedentes:

- Médicos: Cardiopatía coronaria en seguimiento en HLF (descrita como enfermedad de 3 vasos), DLP, HTA, Sobrepeso.
- Quirúrgicos: (-)
- Medicamentos: AAS 100 mg/d, Carvedilol 6.25 mg c/12 hr, Atorvastatina 40 mg/d, Losartán 50 mg/d, Omeprazol 20 mg/d.
- Hábitos: TBQ (-), OH (+) social, Drogas (-)
- Alergias: (-)
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: (-)
- Social: Venezolano, vive desde hace 4 años en Chile, mecánico, vive con esposa, Independiente para todas las actividades
- Inmunizaciones: 4 dosis COVID-19, Flu 2022 (-)

Estudio Cardiológico Previo:

Coronariografía (Feb/21): Enfermedad coronaria severa de 3 vasos

EcoTT (Mar/21): Ventriculo izquierdo no dilatado, levemente hipertrófico, con función sistólica global y segmentaria conservadas. Llenado normal. FE 70%. Aurícula izquierda levemente dilatada. Cavidades derechas normales. Sin valvulopatías

Motivo de consulta: Bypass coronario electivo

Historia de ingreso UCO/ Evolución en UCI (19/06 - 23/06):

Paciente con antecedentes descritos, derivado desde HLF para resolución quirúrgica de Cardiopatía Coronaria con enfermedad de 3 vasos. Ingresa el 19/06 a UCO, sin dolor retro esternal, estable hemodinámicamente, en ritmo sinusal.

Ingresa a pabellón el 20/06 para bypass coronario, LIMA a DA + PAC a DP derecha. Tiempo de CEC 95 minutos, CLAMP Ao 59

Fecha Epicrisis : 25/06/2022 10:30

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 25-06-2022 10:30:23

Página 2 de 2

minutos, tiempo de reperfusión 27 minutos. Sangrado 800 cc con aporte de 1.000 cc SRL + 125 cc de HCO3. Diu 480 cc intra pabellón. BH (+) 1.745.

Ingresa a UCI en el post operatorio inmediato; evoluciona satisfactoriamente, se extuba el 20/06/2022 en horas de la noche, sin interurrencias, evoluciona lúcido, colaborador, dolor con buena respuesta a analgesia, drenajes permeables, en seguimiento por fonoaudiología y terapia ocupacional, inicia alimentación enteral asistida por fonoaudiólogo. Se retiran drenajes el día 23/06 sin incidentes.

Egres a UTIM para continuar manejo, ingresa en buenas condiciones, tendencia a HTA, requerimientos bajos de O2 que suspende rápidamente.

Dolor post operatorio manejado con tramadol + metamizol en BIC.

Se inicia terapia médica óptima con carvedilol, enalapril, espinolactona bien tolerado, inicia ácido acetilsalicílico por indicación de cardiocirugía.

Herida quirúrgica cubierta con apósito, aspecto sano.

Se conversa con Dra. Gaete, se decide alta y control ambulatorio en 2 semanas con cardiocirujano tratante (Dr. Pérez).

Diagnóstico de Egreso

CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA - Enfermedad severa de 3 vasos revascularizada

CRM 20/06

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA - Insuficiencia respiratoria post quirúrgica resuelta

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones, estable, sin dolor, sin oxígeno. En condiciones de alta y control ambulatorio con cardiocirugía.

Plan Post Alta

Reposo relativo

Régimen liviano hiposódico

Doloten (tramadol + paracetamol) comprimidos, 1 comprimido cada 8 horas po 5 días vía oral

Atorvastatina 40 mg al día VO

Omeprazol 20 mg al día VO

Carvedilol 6.25 mg cada 12 horas VO

Enalapril 5 mg cada 12 horas vo

Espironolactona 25 mg al día VO

Ácido acetilsalicílico 100 mg al día VO

Solicitaron control con Dr. Pérez (cardiocirugía) con epicrisis para dos semanas post alta (Primera o segunda semana de Julio) en CDT pasillo 8.

En caso de dolor de pecho, salida de secreción en zona de herida operatoria, fiebre persistente, dificultad para respirar o SOS, acudir a servicio de urgencias.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

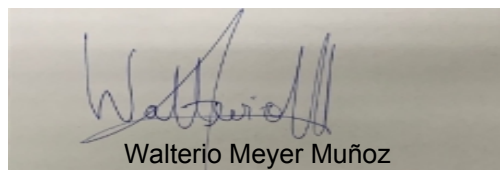
Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Walterio Meyer Muñoz

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 25/06/2022 10:30

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:55

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar